

DUBEMIN INJECTION

(Dung dịch tiêm Thiamin hydroclorid BP 100 mg + Pyridoxin hydroclorid BP 100 mg + Cyanocobalamin BP 1 mg)



- Chỉ sử dụng thuốc này theo đơn.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Không dùng quá liều đã được quy định.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã in trên hộp.

THÀNH PHẦN:

Mỗi ống dung dịch tiêm 3 ml có chứa:

Hoạt chất:	Thiamin hydroclorid (B ₁) BP	100 mg
	Pyridoxin hydroclorid (B ₆) BP	100 mg
	Cyanocobalamin (B ₁₂) BP	1 mg

Tá dược: Natri hydroxid BP 3,0 mg, benzyl alcohol BP 0,03 mg, nước cất pha tiêm BP vừa đủ 3,0 ml.

DƯỢC LỰC HỌC:

Vitamin B₁: Thiamin thực tế không có tác dụng được lý, thậm chí ở liều cao. Thiamin pyrophosphat, dạng thiamin có hoạt tính sinh lý, là coenzym chuyển hóa carboxylat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha-cetoacid như pyruvat và alpha ketoglutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat. Khi thiếu hụt thiamin, sự oxy hóa các alpha ketoacid bị ảnh hưởng, làm nồng độ pyruvat trong máu tăng lên, giúp chẩn đoán tình trạng thiếu thiamin.

Vitamin B₆: Khi vào cơ thể sẽ biến đổi thành pyridoxal phosphat và một phần thành pyridoxamin phosphat. Hai chất này hoạt động như những coenzym trong chuyển hóa protein, glucid và lipid. Pyridoxin tham gia tổng hợp acid γ -aminobutyric (GABA) trong hệ thống thần kinh trung ương và tham gia tổng hợp hemoglobin.

Vitamin B₁₂: Hai dạng Vitamin B₁₂, cyanocobalamin và hydroxycobalamin đều có tác dụng tạo máu. Trong cơ thể người, các cobalamin này tạo thành các coenzym hoạt động là methylcobalamin và 5-deoxyadenosylcobalamin rất cần thiết cho tế bào sao chép và tăng trưởng. Methylcobalamin rất cần để tạo methionin và dẫn chất là S-adenosylmethionin từ homocystein.

Khi nồng độ vitamin B₁₂ không đủ sẽ gây ra sự giảm chức năng của một số dạng acid folic cần thiết khác trong tế bào. Bất thường huyết học ở các người bệnh thiếu vitamin B₁₂ là do quá trình này. Vitamin B₁₂ rất cần thiết cho tất cả các mô có tốc độ sinh trưởng tế bào mạnh như các mô tạo máu, ruột non, tủy xương. Thiếu vitamin B₁₂ cũng gây hủy myelin sợi thần kinh.

Vitamin B₁, B₆, B₁₂ không những có hoạt tính riêng lẻ mà còn kết hợp với nhau như một kết quả của sự liên kết hóa sinh tạo cân bằng trong việc sử dụng dạng kết hợp của chúng và có ý nghĩa đặc biệt trong chuyển hóa của hệ thần kinh. Những nghiên cứu trên động vật cho thấy sự kết hợp của các vitamin B làm tăng các quá trình chuyển hóa thần kinh và các sợi thần kinh, cuối cùng tăng cường sự hồi phục chức năng và củng cố các cơ.

Ở một vài dạng da trên chuột, hiệu quả của việc kết hợp vitamin B₁, B₆, B₁₂ đã chứng minh tác dụng chống lại các tổn thương da do vitamin B₁₂ cho các mô khác. Vitamin B₁₂ rất cần thiết cho tất cả các mô có tốc độ sinh trưởng tế bào mạnh như các mô tạo máu, ruột non, tủy xương. Thiếu vitamin B₁₂ cũng gây hủy myelin sợi thần kinh.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Các vitamin B₁, B₆ và B₁₂ hoàn toàn tan trong nước. Chúng dễ dàng được đào thải qua nước tiểu và không tích lũy trong cơ thể.

Vitamin B₁: sự hấp thu thiamin trong ăn uống hàng ngày là do sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Na⁺. Sau khi tiêm bắp, thiamin cũng được hấp thu nhanh, phân bố vào da số các mô và sụn.

Ở người lớn, khoảng 1 mg thiamin bị giải hấp mỗi ngày trong các mô và đây chính là lượng tối thiểu cần hàng ngày. Khi hấp thu ở mức này, có rất ít hoặc không thấy thiamin thải trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu quá nhiều, thiamin thải trừ qua nước tiểu dạng không đổi.

Vitamin B₆: pyridoxin hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa trừ trường hợp mắc các hội chứng kém hấp thu. Sau khi tiêm hoặc uống, thuốc phân bố dự trữ ở gan và một phần ở cơ và não. Pyridoxin thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng chuyển hóa. Lượng đưa vào, nếu vượt quá nhu cầu hàng ngày, phần lớn đào thải dưới dạng không biến đổi.

Vitamin B₁₂: dạng thiamin qua ruột, chủ yếu ở hồi tràng. Sau khi tiêm bắp, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 1 giờ. Sau khi hấp thu, vitamin B₁₂ liên kết với transcobalamin II và được loại nhanh khỏi huyết tương để phân bố ưu tiên vào nhu mô gan. Gan chính là kho dự trữ vitamin B₁₂ cho các mô khác. Khoảng 3 μ g cobalamin thải trừ vào mật mỗi ngày, trong đó 50-60% là các dẫn chất của cobalamin không được tái hấp thu lại được.

CHỈ ĐỊNH:

Viêm dây thần kinh, đau dây thần kinh, viêm đa dây thần kinh (do nghiện rượu), viêm dây thần kinh thị giác, đau dây thần kinh hông, cổ cánh tay.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Thuốc dùng theo đường tiêm bắp. Trong trường hợp bệnh nặng tiêm bắp sâu mỗi ngày 1 ống cho đến khi các triệu chứng cấp tính giảm. Đối với các trường hợp bệnh nhẹ và điều trị theo dõi thì sử dụng 1 ống mỗi lần, 2-3 lần mỗi tuần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không dùng nạp vitamin B₁.

Ưc tính: vì vitamin B₁₂ làm tăng trưởng các mô có tốc độ sinh trưởng cao nên có nguy cơ làm u tiền triển.

KHUYẾN CÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Không dùng Dubemin Injection với levodopa (vitamin B₆ làm mất tác dụng của levodopa vì nó kích thích enzym dopacarboxylase ngoại vi).
Khi dùng pyridoxin với liều 200 mg/ngày trong thời gian dài có thể có biểu hiện độc tính thần kinh (như bệnh thần kinh ngoại vi nặng và bệnh thần kinh cảm giác nặng). Dùng liều 200 mg/ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc pyridoxin.
Do thuốc có chứa benzyl alcohol, do đó không nên dùng thuốc cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Liều dùng của vitamin B₆ dưới 25mg/ngày có thể được sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú, tuy nhiên do chế phẩm có chứa 100 mg vitamin B₆ nên không nên sử dụng trong thời kỳ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

THUỐC TÁC THUỐC:

Vitamin B₆ làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson, điều này không xảy ra với các chế phẩm là hỗn hợp levodopa-carbidopa hoặc levodopa-benserazid. Liều dùng 200 mg/ngày có thể gây giảm 40-50% nồng độ phenytoin và phenobarbiton trong máu người bệnh. Isoniazid làm tăng tác dụng đối kháng với vitamin B₆. Cycloserin, hydralazin là đối kháng với vitamin B₆.

Thuốc tránh thai đường uống có thể làm tăng nhu cầu về pyridoxin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Quá mẫn: ngứa, mề đay, ban đỏ, shock.

Nước tiểu đỏ.

Trong trường hợp không dung nạp vitamin B₆ có các triệu chứng: buồn nôn, chuột rút, phản ứng ngứa da, có thể xảy ra sốc, khi đó nên ngừng thuốc và dùng các biện pháp điều trị thích hợp.

Thông tin tác dụng không mong muốn của từng thành phần riêng lẻ:

Vitamin B₁: Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường nhẹ kiểu dị ứng. Các phản ứng quá mẫn xảy ra chủ yếu khi tiêm. Sốc quá mẫn chỉ xảy ra khi tiêm, và chỉ tiêm thiamin đơn độc; nếu dùng phối hợp với các vitamin B khác thì phản ứng không xảy ra. Bình thường do thiamin tăng cường tác dụng của acetylcholin, nên một số phản ứng da có thể coi như phản ứng dị ứng.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000

Toàn thân: Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn.

Tuần hoàn: Tăng huyết áp cấp.

Da: Ban da, ngứa, mề đay.

Hô hấp: Khó thở.

Phản ứng khác: Kích thích lại chỗ tiêm.

Vitamin B₁₂: Dùng liều 200 mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ ngón đi không vững và tê cứng bàn chân đến tê cứng và vùng vụng về bàn tay. Tình trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000

Buồn nôn và nôn.

Vitamin B₁₂: Các phản ứng dị ứng do miễn dịch tuy hiếm, nhưng đôi khi rất nặng có thể gây chết người sau khi tiêm các chế phẩm có cobalamin.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000

Toàn thân: Phản vệ, sốt.

Ngoài da: Phản ứng dạng trứng cá, mề đay, ngứa, đỏ da.

Ghi chú: XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CÁC TÁC DỤNG NGOẠI Ỗ GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC.

QUÁ LIỀU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Báo cáo về các trường hợp quá liều liên quan đến dung dịch tiêm Vitamin B rất hạn chế, chủ yếu liên quan đến quá liều vitamin B₆. Triệu chứng quá liều có thể gồm chóng mặt, liệt liệt, giảm xúc giác, giảm thân nhiệt, mệt mỏi, các triệu chứng này có thể kéo dài đến 6 tháng.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Số lô sản xuất (Batch No.), ngày sản xuất (Mfg. date), hạn dùng (Exp. date): xin xem trên nhãn hộp và ống.

ĐÓNG GÓI VÀ DẠNG BẢO CHẾ:

Hộp chứa 5 ống x 3 ml dung dịch tiêm.

Sản xuất bởi:

INCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITED

Dewan Idris Road, Zirabo, Savar, Dhaka, Bangladesh.

V.N.02